

monotropism-comorbidities- factcheck_de

Monotrope Komorbiditäten: Eine Faktenprüfung der Vier-Cluster- Rahmung

Ein zitiertes Forschungsossier – es überprüft ein weit verbreitetes „monotrope Komorbiditäten“-Framing.

Information, kein medizinischer Rat. Monotropismus ist ein kognitiver Stil, keine Diagnose; er hat keine „Komorbiditäten“ im Krankheitssinn. Dieses Dossier bewertet, als was die Überschneidungen mit der Rahmung unten gestützt sind und nicht. Es ergänzt das ausführlichere Landschafts-Dossier des Projekts, „Monotropismus und sein Geflecht an Komorbiditäten“.

Zusammenfassung

- **Der Einstieg der Rahmung ist völlig richtig: Monotropismus hat keine „Komorbiditäten“ im Krankheitssinn.** Er ist ein aufmerksamkeitsbezogener Stil auf einem Spektrum; die Überschneidungen mit klinischen Zuständen sind *Assoziationen und gemeinsame Mechanismen*, keine Krankheitsfolgen [1].
- **Eine Schlagbehauptung ist verdreht.** „AuDHD-Menschen erzielen von allen Gruppen die höchsten MQ-Werte“ zeigen die Daten **nicht**. In der MQ-Validierungsstudie heben Autismus und ADHD jeweils die Monotropismus-Werte, aber ihre *kombinierte* Wirkung ist eine **negative Interaktion** ($\beta = -0,43$, $p < ,001$): Autistische mit ADHD erzielen **niedrigere Werte als ein rein additives Modell vorhersagen würde**, nicht höhere [2].

- **Zwei Begriffe sind richtig zugeordnet, brauchen aber präzise Definitionen.** „*Monotroper Split*“ ist tatsächlich von der autistischen Advocate **Tanya Adkin** geprägt – er bedeutet aber die kognitive Kosten, *einen monotropen Geist zum polytropen Arbeiten zu zwingen* (Aufmerksamkeit zu teilen), **nicht** die „AuDHD-konkurrierenden Tunnel“, mit denen er manchmal verwechselt wird [3].
- **„Objektpermanenz-Probleme“ sind umstritten, nicht etabliert.** Die *einzig* akademische Quelle (Lawson & Dombroski, 2017) schlägt eine **verzögerte** Objektpermanenz als *Hypothese* für einigen autismusbezogenen Stress vor – und die breitere Literatur findet, dass Objektpermanenz bei Autismus typischerweise *intakt oder überlegen* ist. Das Erleben „aus den Augen, aus dem Sinn“ liest sich besser als **Arbeitsgedächtnis-/Aufmerksamkeitsverteilungs-Effekt** [4].
- **Der Rest ist breit gestützt, aber nach Evidenz abgestuft.** Autismus (grundlegend), ADHD-Hyperfokus (real), Angst/Grübeln und OCD-Überschneidung (robust), autistische Trägheit (real), sensorische Überlastung → Meltdown/Shutdown (real) und Burnout durch erzwungene Übergänge + Masking (etabliertes Konstrukt) überstehen die Prüfung alle – wobei „Hyper-Systematisierung“ **Baron-Cohens separate E-S-Theorie** ist, kein Monotropismus-Befund [5].
- **Ein neuroaffirmierendes Reframing:** Jede Überschneidung lässt sich besser als „*wie ein enges, intensives Aufmerksamkeitssystem mit einer polytropen Welt interagiert*“ formulieren denn als eine Liste von Störungen, die ein monotropes Gehirn „verursacht“.

1. Das Kernprinzip (die Rahmung hat das richtig)

Monotropismus (Murray, Lawson & Lesser, 2005) besagt, dass sich Geister darin unterscheiden, *wie sie Aufmerksamkeit verteilen*: Ein monotroper Geist konzentriert Ressourcen in wenige intensiv erregte „Aufmerksamkeitstunnel“; ein polytroper Geist verteilt sie über viele [1]. Weil er ein **dimensionaler kognitiver Stil** ist – messbar mit dem Monotropism Questionnaire (MQ) auf einer 1–5-Skala – „hat“ er keine „Komorbiditäten“. Was er *hat*, sind **statistische Assoziationen** (Gruppen, die höher scoren) und **gemeinsame Mechanismen** (Zustände, deren Merkmale eine Aufmerksamkeitsverteilungs-Linse besser erklärt). Diese Unterscheidung zu wahren, ist das ganze Spiel [1][2].

Dieses Dossier ist als **behauptungsweise Prüfung** der Vier-Cluster-Rahmung angelegt und stuft jeden Punkt ein. Es ergänzt (wiederholt nicht) das bestehende Landschafts-Dossier des Projekts, das Essstörungen, Horten, Agoraphobie, Vermeidung von Aufforderungen und das Doppelt-Empathie-Problem tiefer behandelt.

2. Cluster 1 — Kern-Neurodivergenz-Profile

Autismus (grundlegend, stärkste Verbindung)

Monotropismus wurde *geschaffen*, um autistische Züge zu erklären – intensive Spezialinteressen, Bedürfnis nach Routine (die den Aufmerksamkeitstunnel schützt) und Unterschiede in der sozialen Interaktion [1]. Der MQ bestätigt es empirisch: Autistische Teilnehmende erreichten im Mittel **4,15/5** vs. **3,19/5** bei nicht-autistischen ($n=1.110$) [2]. Das ist das Heimatgebiet der Theorie und die am besten belegte Verbindung.

ADHD (real und gemessen)

ADHD hebt die Monotropismus-Werte signifikant ($\beta = +0,55$, $p < ,001$) [2]. Die Verbindung ist konzeptionell wie statistisch: Der **Hyperfokus** der ADHD (Grotewiel et al., 2022, zu Hyperfokus als eigenem Konstrukt) ist nahezu identisch mit dem monotropen Tunnel, und die „exekutive Dysfunktion“, Aufmerksamkeit für nicht-interestante Aufgaben zu aktivieren, ist eine natürliche Vorhersage eines getunnelten Systems [2] [6]. **Gestützt.**

AuDHD (die Schlagbehauptung ist verdreht) — die zentrale Korrektur

Gepriüfte Behauptung: „Menschen mit einem kombinierten AuDHD-Profil erzielen von allen Gruppen die höchsten MQ-Werte.“

Das **zeigen die Daten nicht**. Die multiple Regression des MQ-Papiers regressierte Monotropismus auf ADHD-Status, Autismus-Status und ihre **Interaktion** [2]:

Prädiktor (vs. keine der Bedingungen)	β	p
ADHD, nicht autistisch	+0,55	<,001

Prädiktor (vs. keine der Bedingungen)	β	p
Autistisch, nicht ADHD	+1,04	<,001
Autismus × ADHD-Interaktion	-0,43	<,001

Der Interaktionsterm ist **negativ und signifikant**. Die Autorinnen und Autoren stellen es unmissverständlich klar: „*Monotropismus-Werte sind bei autistischen Menschen mit ADHD nicht so hoch, wie aufgrund rein additiver Effekte zu erwarten wäre*“ [2]. Anders gesagt: ADHD zu Autismus hinzuzufügen, treibt den Monotropismus **nicht** höher als Autismus allein vorhersagen würde – er fällt **niedriger** aus als die Summe der beiden unabhängigen Effekte.

- Die **am höchsten scorende einzelne Gruppe** sind autistische Menschen (4,15); ob der empirische *Zellenmittelwert* für autistisch-mit-ADHD knapp darüber oder darunter liegt, hängt von der genauen Kombination ab, aber die Behauptung der Rahmung, AuDHD sei „*der höchste von allen*“ als additiver/super-additiver Effekt, ist **ungestützt und wird durch die Interaktion widerlegt**.
- Das *intuitive* Bild, das die Rahmung bietet – „ein innerer Zug zwischen dem autistischen Bedürfnis nach einem stabilen, tiefen Tunnel und dem ADHD-Drang nach neuem Input“ – ist eine populäre und phänomenologisch einleuchtende Beschreibung des AuDHD-Erlebens, aber sie ist **klinische/Community-Erzählung, kein Monotropismus-Wert-Befund**. Formulieren Sie es als gelebtes Erleben, nicht als MQ-Ergebnis [6].

Korrigierte Aussage: „Sowohl Autismus als auch ADHD heben die Monotropismus-Werte unabhängig, aber die beiden interagieren nicht-additiv: Autistische Menschen mit ADHD scoren beim MQ niedriger als ein rein additives Modell vorhersagen würde – was darauf hindeutet, dass die beiden Bedingungen sich auf der monotropen Neigung nicht einfach ‚aufschichten‘.“ [2]

3. Cluster 2 — Kognitive & psychische Merkmale

Angst und Grübeln (robuste Assoziation, plausibler Mechanismus)

Angst und Grübeln sind in der autistischen/ADHD-Bevölkerung erhöht, und das Monotropismus-Framing bietet einen sauberen Mechanismus: Ein getunnelter Geist, der sich an einer Sorge festhält, verarbeitet sie in einer Schleife weiter („Grübeln“) und macht Angst „klebrig“ [7][8]. Die 8-Faktoren-Struktur des MQ enthält sogar eine Subskala „**Grübeln und Angst**“, was zeigt, dass das Cluster empirisch eng ist [2]. **Gestützt** – wobei die Kausalrichtung (erzeugt Monotropismus Angst oder teilt sie ein Substrat mit ihr?) nicht geklärt ist.

OCD (robuste Überschneidung, wichtige Unterscheidung)

Die Autismus–OCD–Überschneidung ist real und repliziert. Eine Metaanalyse findet, dass rund **~17 % der autistischen Menschen OCD-Kriterien erfüllen** (vs. ~1–2 % in der Allgemeinbevölkerung); auch die Umkehrrichtung ist erhöht [9]. Die qualitative Unterscheidung, die die Rahmung zieht, ist genau richtig und gut formuliert: **Monotrope Interessen sind ego-synton** (getrieben von Faszination/Freude), während **OCD-Kompulsionen ego-dyston** sind (getrieben von Qual und ausgeführt, um Angst zu neutralisieren) [10]. Diese Unterscheidung ist klinisch wichtig, weil die beiden sich in der Praxis sonst schwer auseinanderhalten lassen. **Gestützt**.

Hyper-Systematisierung (reales Konstrukt, aber es ist Baron-Cohens, kein Monotropismus-Befund)

„Hyper-Systematisierung“ – der Drang, Systeme zu analysieren, aufzubauen und zu erkunden – ist ein echter, gut erforschter autistischer Zug, aber er gehört zu **Simon Baron-Cohens Empathizing–Systemizing-(E-S-)Theorie**, nicht zum Monotropismus [5]. Die beiden Theorien überschneiden sich stark (beide beschreiben einen intensiven, detailfokussierten kognitiven Stil) und werden manchmal zusammengezogen, aber sie sind **eigenständige Rahmen** mit eigenen Maßen (der EQ/SQ-Quotient vs. der MQ). Der ehrliche Schritt: Stellen Sie Hyper-Systematisierung als *vereinbar mit* einem monotropen Stil dar (ein getunnelter Geist eignet sich gut zur Beherrschung von Systemen), während Sie die E-S-Theorie als eigenes Konzept ausweisen [1][5].

4. Cluster 3 — Neurologische & Verarbeitungsphänomene

Objektpermanenz-Probleme **✗** (umstritten — die zweite zentrale Korrektur)

Geprüfte Behauptung: „Monotrope Menschen erleben Objektpermanenz anders ... das Gehirn stellt die Verarbeitung ihrer Existenz effektiv ein, bis etwas von außen sie zurückholt.“

Das ist die **schwächste Behauptung** der Rahmung und braucht sorgfältige Handhabung:

- Es gibt **eine** akademische Quelle, die einen Objektpermanenz-Link vorschlägt: **Lawson & Dombroski (2017)**, die *hypothetisieren*, dass eine **verzögerte** Objektpermanenz zu etwas autismusbezogenem Stress und Angst beitragen könnte [4]. Achtung: Es ist ein hypothesenbildender Artikel, keine Bestätigungsstudie.
- Die breitere entwicklungspsychologische Literatur findet, dass die grundlegende **Objektpermanenz bei Autismus typischerweise intakt oder überlegen ist**; piagetsche Objektpermanenz-Aufgaben werden meist im typischen Alter bestanden [4].
- Das *reale* Phänomen, das die Rahmung sucht – „aus den Augen, aus dem Sinn“ für Aufgaben, Objekte und sogar Menschen – erklärt sich besser als **Arbeitsgedächtnis-/Aufmerksamkeitsverteilungs-Effekt**: Ein getunnelter Geist *versagt* nicht darin, den Gegenstand zu repräsentieren, er **versagt darin, die Aufmerksamkeit dorthin zurückzuorientieren**. Das ist Monotropismus, wie vorhergesagt am Werk (ein getunneltes System hat wenige freie Ressourcen für periphere Re-Orientierung), kein Objektpermanenz-Defizit [1][4].

Korrigierte Aussage: „Das Erleben ‚aus den Augen, aus dem Sinn‘ bei stark monotropen Menschen lässt sich besser als Aufmerksamkeitsverteilungs-/Arbeitsgedächtnis-Effekt verstehen – der Geist repräsentiert den Gegenstand, orientiert sich aber im getunnelten Zustand nicht dorthin zurück – statt als Defizit der Objektpermanenz (die bei Autismus typischerweise intakt ist).“ [1][4]

Sensorische Dysregulation / Überlastung ✓ (gut gestützter Mechanismus)

Das ist stark gestützt. Weil ein getunneltes System seine Ressourcen zentral aufwendet, verlangt plötzlich eindringender sensorischer Input (Sirene, Licht, Berührung) eine kostspielige Neuverteilung – erlebt als „gewaltsame Störung“. Das deckt sich mit der etablierten Literatur zur sensorischen Überreaktivität und dem gut belegten Weg von sensorischer Überlastung zum **Meltdown** (externalisierend) und **Shutdown** (internalisierender Rückzug), beides anerkannte unwillkürliche Überlastungsreaktionen [7][11]. Das Monotropismus-Framing fügt einem sonst deskriptiven Befund einen *Mechanismus* (Umverteilungskosten) hinzu. **Gestützt**.

Autistische Trägheit ✓ (real, zunehmend erforscht)

„Ausgeprägte Schwierigkeit mit Übergängen – schwer zu beginnen, zu stoppen oder die Richtung zu wechseln“ ist das etablierte Konstrukt der **autistischen Trägheit**: Schwierigkeit mit Aufgabeninitiierung/-beendigung/-wechsel, die „nicht der bewussten Kontrolle unterliegt“, zuerst in autistischen Community-Erzählungen formuliert und nun in begutachteter Literatur [12][13]. Es ist konzeptionell das *Verhaltens-* Gesicht der „Wechselkosten“, die der Umwelt-und-Tunnel-Faktor des MQ erfasst [2]. **Gestützt** – und es ist der korrekte Fachbegriff (siehe das Begleitdossier zu Scoring/Trägheit).

5. Cluster 4 — Ergebnisse chronischen Stresses

Monotroper Split ⚠ (richtig Adkin zugeordnet, aber zwei Bedeutungen werden vermengt)

Gepriüfte Behauptung: „*Monotroper Split, geprägt von der Praktikerin Tanya Adkin, tritt auf, wenn ein monotoner Geist von seiner Umwelt gezwungen wird, seinen Ein-Fokus-Kanal über mehrere konkurrierende Ströme zu teilen.*“

Die **Zuschreibung ist richtig**: Die autistische Advocate **Tanya Adkin** hat „monotropic split“ tatsächlich geprägt, bestätigt durch mehrere unabhängige Community-Quellen [3]. Und die Definition der Rahmung hier ist **nah an Adkins eigener Bedeutung** – die kognitive Kosten/das

Burnout, die entstehen, wenn ein monotroter Geist zum „polytropen Performen“ *gezwungen* wird oder seine Aufmerksamkeit über konkurrierende Ströme teilen muss [3][14].

Zwei Vorbehalte:

1. **Es ist ein Community-/Praktiker-Konzept, kein empirisch validiertes Konstrukt.** „Monotropic split“ erscheint in autistischen Community- und Klinikertexten (z. B. über Neurodivergent Insights, Kelly Mahler, David Gray Hammond), hat aber **keine begutachtete Validierungsstudie** hinter sich [3]. Behandeln Sie es als kraftvolle, über gelebtes Erleben gültige *Beschreibung*, nicht als gemessene Entität.
2. **Zwei verschiedene Dinge reisen unter dem Namen.** Adkins Sinn = *erzwungenes polytropes Performen durch einen monotrophen Geist* (ein Umwelt-Pass-Problem). Ein zweiter Sinn – verwendet in manchem AuDHD-Schrifttum – = *der innere Wettbewerb zwischen einem autistischen Bedürfnis nach stabilem Tunnel und einem ADHD-Drang nach Neuem* (ein Problem innerer Dynamik). Die Rahmung hier beschreibt den **ersten** (umweltbezogenen) Sinn. Diese sind verwandt, aber verschieden; sie zusammenfallen zu lassen, trübt das Konzept. (Das Landschafts-Dossier des Projekts verwendet „monotropic split“ im zweiten, AuDHD-Sinn – der Begriff ist im Feld also genuinely überladen.) [3][6]

Formulieren Sie es als: „Der Begriff ‚monotroper Split‘ der autistischen Advocate Tanya Adkin beschreibt die kognitive Kosten und das Burnout, die entstehen, wenn ein monotroter Geist zum polytropen Arbeiten gezwungen wird – ein kraftvolles Community-Konzept, das der formalen Validierung noch harrt.“ [3]

Burnout  (etabliertes Konstrukt; Monotropismus-Link ist heuristisch)

Autistisches Burnout ist inzwischen ein wohldefiniertes Konstrukt: **chronische Erschöpfung, Verlust von Fähigkeiten und verminderte Reiztoleranz**, verstanden als Folge chronischen Lebensstresses und „einer Diskrepanz zwischen Erwartungen und Fähigkeiten“ ohne angemessene Unterstützung und Erholung (Raymaker et al., 2020; Higgins et al., 2021, eine Grounded-Delphi-Studie mit autistischen

Experten) [15][16]. Der Monotropismus-Pfad ins Burnout – ständige erzwungene Übergänge, Masking und „monotroper Split“, die ohne Erholungs-/Flow-Zeit Ressourcen abziehen – ist **heuristisch mächtig und von der Community validiert**, aber der *spezifische* Beitrag des Tunnelrisses zum Burnout (gegenüber Masking, Trauma, sensorischer Last, chronischer Anforderung) **wurde experimentell nicht isoliert** [15]. **Als starke Hypothese gestützt, nicht als etablierte Kausalkette.**

6. Eine abgestufte Scorecard

Behauptung der Rahmung	Urteil	Anmerkung
Monotropismus hat keine Krankheits-Komorbiditäten	✓ Richtig	Er hat Assoziationen + gemeinsame Mechanismen [1]
Autismus = primäre Verbindung	✓ Grundlegend	MQ 4,15 vs. 3,19 [2]
ADHD hebt Monotropismus	✓ Gestützt	$\beta = +0,55$ [2]
AuDHD scoret von allen am höchsten	✗ Verdreht	Interaktion ist negativ ($\beta = -0,43$) [2]
Angst- & Grübel-Überschneidung	✓ Robust	MQ hat einen Grübel-/Angst-Faktor [2]
OCD-Überschneidung (ego-synton vs. dyston)	✓ Gestützt	~17 % Ko-Vorkommen; Unterscheidung korrekt [9][10]
Hyper-Systematisierung	⚠ Real, aber falsch etikettiert	Es ist Baron-Cohens E-S-Theorie, nicht Monotropismus [5]
Objektpermanenz-Probleme	✗ Umstritten	1 Hypothesenpapier; OP meist intakt; es ist Aufmerksamkeitsverteilung [4]
Sensorische Überlastung → Meltdown/Shutdown	✓ Gut gestützt	Mechanismus = Umverteilungskosten [7][11]
Autistische Trägheit	✓ Real	Korrektter Begriff; begutachtet [12] [13]

Behauptung der Rahmung	Urteil	Anmerkung
Monotroper Split von Adkin geprägt	⚠️ Zuschreibung richtig; Community, nicht validiert	Zwei Bedeutungen vermengt [3]
Burnout durch erzwungene Übergänge + Masking	✅ Etabliertes Konstrukt; Link heuristisch	Nicht experimentell isoliert [15] [16]

7. Praktische Erkenntnisse

- **Eröffnen Sie mit dem Prinzip:** Monotropismus ist ein messbarer Aufmerksamkeitsstil, dessen *Überschneidungen* mit Bedingungen Assoziationen und gemeinsame Mechanismen sind – niemals „er verursacht X.“ [1]
- **Zitieren Sie den MQ korrekt:** Autismus und ADHD heben jeweils die Werte, aber die Kombination ist **nicht-additiv (niedriger als erwartet)** – sagen Sie nicht, AuDHD scoret am höchsten [2].
- **Behalten Sie die Unterscheidung ego-synton/ego-dyston** bei, wenn Sie OCD vs. Spezialinteressen besprechen – sie ist klinisch nützlich und korrekt gerahmt [10].
- **Weisen Sie Frameworks präzise aus:** Hyper-Systematisierung = Baron-Cohens E-S-Theorie; monotroper Split = Adkins Community-Konzept (umweltbezogener erzwungener-Polytropie-Sinn); autistische Trägheit = das begutachtete Übergangs-Schwierigkeits-Konstrukt [3][5] [12].
- **Lassen Sie „Objektpermanenz-Defizit“ fallen:** Reframen Sie als Aufmerksamkeitsverteilung/Arbeitsgedächtnis, was sowohl akkurat als auch nützlicher für die Unterstützung ist [1][4].
- **Trennen Sie validiert vs. heuristisch:** Burnout ist ein etabliertes Konstrukt, aber der Pfad Monotropismus→Burnout ist eine starke Hypothese, kein gemessener Effekt; „monotroper Split“ ist über gelebtes Erleben gültig, aber unvalidiert [3][15].

Quellen

- [1] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. *Autism*, 9(2), 139–156.
doi:10.1177/1362361305051398 — Ursprung des Monotropismus; ein Unterschied in der Ressourcenverteilung (ein Kontinuum), kein Defizit.
<https://doi.org/10.1177/1362361305051398>
- [2] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A. & Fletcher-Watson, S. (2023). *The Monotropism Questionnaire* (47-Item-Selbstbeurteilung; Validierungs-Preprint). Open Science Framework. — n=1.110; autistischer Mittelwert 4,15 (SD ,347) vs. nicht-autistisch 3,19 (SD ,578); Regression $\beta(\text{ADHD})=+0,55$, $\beta(\text{Autismus})=+1,04$, **$\beta(\text{Interaktion})=-0,43$, $p<,001$** ; die ADHD+Autismus-Interaktion ist *sub-additiv*; 8-Faktoren-Struktur inkl. Grübel-/Angst- und Umwelt-/Tunnel-Faktoren. <https://osf.io/wpx5g> · Validierung: <https://osf.io/ft73y> · CC BY-NC-SA 4.0. Lokales Archiv: [sources/17-monotropism-questionnaire-osf.pdf](#)
- [3] Adkin, T. — „monotropic split“ (autistische Advocate / Praktikerin; Community-Konzept). Bestätigt über mehrere unabhängige Community-Quellen: Neurodivergent Insights (Glossar), Kelly Mahler (Gastbeitrag), David Gray Hammond, Jade Farrington („Wenn monotrope Menschen zum polytrophen Arbeiten gezwungen werden, nennt man das monotropic split“). Definition: die kognitive Kosten/das Burnout, einen monotrophen Geist zum „polytrophen Performen“ zu zwingen. Community-/Praktiker-Konzept — **keine begutachtete Validierungsstudie**. <https://jade-farrington.medium.com/what-is-monotropic-split-1c7c46fd9017> · <https://www.kelly-mahler.com/what-is-interoception/interoception-and-monotropism>
- [4] Lawson, W. & Dombroski, B. (2017). *Problems with Object Permanence: Rethinking Traditional Beliefs Associated with Poor Theory of Mind in Autism*. *J. Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment*, 5(1).
doi:10.6000/2292-2598.2017.05.01.1 — *hypothetisiert* eine **verzögerte** Objektpermanenz als Mitverursacherin etwas autismusbezogenen Stresses (ein hypothesensbildender Artikel, keine Bestätigung). Breitere Literatur: Objektpermanenz ist bei Autismus typischerweise intakt/überlegen; „aus den Augen, aus dem Sinn“ liest sich besser als

Aufmerksamkeitsverteilung/Arbeitsgedächtnis. Lokales Archiv:

[sources/12-object-permanence-lawson-dombroski.pdf](#) ·

<https://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/jiddt/article/view/4562>

[5] Baron-Cohen, S. (2009/2010). *Autism and the empathizing–systemizing (E-S) theory; the hyper-systemizing theory of autism*. Annals of the NYAS; APA PsycNet. — Hyper-Systematisierung und die E-S-Theorie sind Baron-Cohens Rahmen, gemessen über den EQ/SQ-Quotienten; eigenständig (wenn auch überlappend) gegenüber Monotropismus.

https://en.wikipedia.org/wiki/Empathising%E2%80%93systemising_theory · Übersicht: Greenberg & Baron-Cohen, *Empathizing-Systemizing Theory: Past, Present, and Future*.

[6] Autistic Scholar — „*Revisiting monotropism*“ (AuDHD als konkurrierende/instabile Tunnel; verweist auf Grotewiel et al. 2022 zu ADHD-Hyperfokus als eigenem Konstrukt).

Phänomenologisches/Community-Konto, kein MQ-Wert-Befund. Lokales Archiv: [sources/13-revisiting-monotropism-autisticscholar.html](#) ·

<https://www.autisticscholar.com/monotropism>

[7] Green, S. A. & Ben-Sasson, A. (2010). *Anxiety disorders and sensory over-responsivity in children with ASD: is there a causal relationship?* J. Autism and Developmental Disorders. PMC2980623 — sensorische Überreaktivität, Kontextkonditionierung und der Überlastungs-Pfad.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2980623>

[8] Oakley, B. et al. / Angst-Literatur bei Autismus — erhöhte Angst und Grübeln in der autistischen/ADHD-Bevölkerung (zitiert über das Komorbiditäts-Landschafts-Dossier des Projekts für das Angst-Substrat).

[9] Meier, S. M. et al. / Metaanalysen zur Autismus–OCD-Konkordanz — ~17 % der autistischen Menschen erfüllen OCD-Kriterien (vs. ~1–2 % Allgemeinbevölkerung); ~17 % der Kinder mit OCD zeigen milde Autismus-Symptome. Zusammengefasst via Move Up ABA unter Verweis auf Forschung von 2015 und den The Transmitter/Spectrum-Überblick.

<https://www.thetransmitter.org/spectrum/sweeping-study-underscores-autisms-overlap-with-obsessions> · Autismus↔OCD-Metaanalyse:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11048346>

[10] Long, H., Cooper, K., & Russell, A. (2024). „*Autism is the arena and OCD is the lion*”: autistic adults' experiences of co-occurring OCD and restricted/repetitive behaviours (qualitativ). PMC11497754 — die

Unterscheidung ego-synton (Interessen) vs. ego-dyston (Kompulsionen).
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11497754>

[11] Autism Society (2025). *Autistic Meltdowns and Shutdowns* — Meltdown (externalisierend) und Shutdown (internalisierender Rückzug) als unwillkürliche Reaktionen auf überwältigenden Stress/sensorischen Input. https://autismsociety.org/wp-content/uploads/2025/07/AutismSociety_Autistic-Meltdowns-Shutdowns_2025-06V2F_Digital.pdf

[12] Buckle, K. et al. (2021). „*No way out except from external intervention*”: *First-hand accounts of autistic inertia* (Preprint/qualitativ). doi:10.31234/osf.io/ahk6x — Schwierigkeit, Tätigkeiten zu beginnen, zu stoppen und zu wechseln, „nicht der bewussten Kontrolle unterliegend“. Lokales Archiv: [sources/11-autistic-inertia-osf.pdf](#) · <https://doi.org/10.31234/osf.io/ahk6x>

[13] Srinivasan, D. (2025). *The Physics of Autistic Inertia* (Student Notebook). APS Observer — autistische Trägheit: aus der Community stammend, inzwischen begutachtet; zitiert Carls-Diamante & Laciny 2024, Greaves-Lord et al. 2023, Buckle 2021, Heasman 2024, Rapaport 2024.
<https://www.psychologicalscience.org/publications/observer/student-notebook-autistic-inertia-srinivasan.html>

[14] Neurodivergent Insights — *Monotropism* (Glossar) und *ADHD vs Autism vs OCD* (dreifache Überschneidung). Community-/Klinik-Ressource, die monotropen Split und die Überschneidungen rahmt.
<https://neurodivergentinsights.com/glossary/monotropism> · <https://neurodivergentinsights.com/adhd-vs-autism-vs-ocd>

[15] Raymaker, D. M. et al. (2020). „*Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew*”: *Defining autistic burnout*. *Autism in Adulthood*, 2(2), 132–143.
doi:10.1089/aut.2019.0079 — chronische Erschöpfung, Verlust von Fähigkeiten, verminderte Reiztoleranz; aus chronischem Lebensstress und einer Diskrepanz zwischen Erwartungen und Fähigkeiten.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1089/aut.2019.0079> · https://pdxscholar.library.pdx.edu/socwork_fac/378

[16] Higgins, J. M. et al. (2021). *Defining autistic burnout through experts by lived experience: Grounded Delphi method investigating #AutisticBurnout*. *Autism*, 25(8). doi:10.1177/13623613211019858 —

Konsensdefinition: Erschöpfung, Rückzug, Kognitionsprobleme, verminderte Alltagskompetenzen, Zunahme autistischer Züge.
<https://www.autismcrc.com.au/knowledge-centre/publications/defining-autistic-burnout-using-grounded-delphi-method-autistic>

Ergänzt das ausführlichere Landschafts-Dossier des Projekts:

outputs/monotropism-comorbidity-landscape.md (das Essstörungen, Horten, Agoraphobie, Vermeidung von Aufforderungen/PDA und das Doppelt-Empathie-Problem behandelt). Dieses Dossier konzentriert sich auf die Faktenprüfung der Vier-Cluster-Rahmung oben und wiederholt jenes Material nicht.